

Редакция от 22 апр 2013

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 923н

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#).
2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 1183н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19645).

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано

в

Российской

29

регистрационный № 26482

Министерстве

декабря

2012

юстиции

Федерации

года,

УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 года № 923н

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "Терапия"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" в медицинских организациях (далее - медицинская помощь).
2. Медицинская помощь оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи.

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Медицинская помощь оказывается в форме:

экстренной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи;

плановой медицинской помощи, оказываемой при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

5. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

6. Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому принципу в соответствии с [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 года, регистрационный № 24726).

7. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в медицинских организациях и их подразделениях осуществляется на основе взаимодействия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-специалистов, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю заболевания пациента (врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачей-эндокринологов, врачей-гастроэнтерологов и других).

8. При затруднении в диагностике и выборе лечебной тактики, а также при осложненном течении заболевания и при наличии медицинских показаний для лечения пациента врачом-специалистом по профилю его заболевания, врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) направляет пациента на консультацию к врачу-специалисту в соответствии с профилем его заболевания и в последующем осуществляет наблюдение за клиническим состоянием пациента, его лечение в соответствии с рекомендациями врача-специалиста по профилю заболевания.

9. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях и (или) при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт-участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) по согласованию с врачом-специалистом по профилю заболевания пациента направляет его в медицинскую организацию для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях.

10. В случае невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях или в стационарных условиях терапевтического отделения, пациент в плановом порядке направляется в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь и имеющую в своем составе соответствующие специализированные отделения для проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

11. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний терапевтического профиля, не опасных для жизни и не требующих медицинской помощи в экстренной форме или лечения в стационарных условиях, первичная медико-санитарная помощь может оказываться службой неотложной

медицинской помощи, созданной в структуре медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

12. При выявлении медицинских показаний к оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, при невозможности ее оказания в условиях медицинской организации, в которой находится пациент, пациента безотлагательно доставляют, в том числе бригадой скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, имеющую в своем составе специализированные отделения, для оказания необходимой медицинской помощи.

13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь осуществляется фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, в соответствии с [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 года № 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 года, регистрационный № 6136) с изменениями, внесенными [приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 586н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 года, регистрационный № 18289), [от 15 марта 2011 года № 202н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 года, регистрационный № 20390), [от 30 января 2012 года № 65н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 года, регистрационный № 23472).

14. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

15. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.

16. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в стационарных условиях или в условиях дневного стационара врачами-специалистами по профилю заболевания пациента и включает диагностику, лечение заболеваний, требующих специальных методов диагностики и использования сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

17. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при

вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у пациентов с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи, приведенным в [приложении к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи](#), утвержденному [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 года, регистрационный № 17175), а также при наличии у пациента медицинских показаний - в федеральных государственных медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствии с [Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний](#), утвержденным [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 года, регистрационный № 7115).

18. При наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с [Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы](#), утвержденным [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1689н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 года, регистрационный № 23164).

19. После окончания срока оказания медицинской помощи в стационарных условиях дальнейшие тактика ведения и медицинская реабилитация пациента определяется консилиумом врачей.

20. Пациенты при наличии медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации, а также в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь.

21. Оказание медицинской помощи, за исключением первичной медико-санитарной помощи по профилю "терапия", осуществляется в соответствии с [приложениями № 1-9 к настоящему Порядку](#).

Приложение № 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 1. Правила организации деятельности терапевтического кабинета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности терапевтического кабинета, который является структурным подразделением медицинской организации.

2. Терапевтический кабинет (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю "терапия".

3. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#), утвержденному настоящим приказом.

4. На должность врача-терапевта участкового Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым [Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](#), утвержденными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 года, регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1644н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 года, регистрационный № 23879), по специальности "терапия", а также [Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих](#), утвержденного [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 года № 18247).

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи](#)

взрослому населению по профилю "терапия", утвержденному настоящим приказом.

6. Основными функциями Кабинета являются:

формирование терапевтического (цехового) участка из числа прикрепленного к нему населения (работников предприятия, организации), а также с учетом выбора гражданами медицинской организации;

профилактика неинфекционных заболеваний путем предупреждения возникновения, распространения и раннего выявления таких заболеваний, а также снижения риска их развития;

профилактика инфекционных заболеваний, направленная на предупреждение распространения и раннее выявление таких заболеваний, организация проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;

санитарно-гигиеническое образование, формирование здорового образа жизни, информирование населения о факторах риска заболеваний, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;

анализ потребности обслуживаемого населения в оздоровительных мероприятиях и разработка программы проведения этих мероприятий;

обучение населения оказанию первой помощи при неотложных состояниях и заболеваниях, обуславливающих основную часть внегоспитальной смертности населения обслуживаемого участка (внезапная сердечная смерть (остановка) сердца, острый коронарный синдром, гипертонический криз, острое нарушение мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточность, острые отравления и др.);

осуществление диспансерного наблюдения и учета пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями терапевтического профиля, в том числе имеющих право на получение набора социальных услуг, в установленном порядке;

проведение обследования пациентов, обратившихся за медицинской помощью, на предмет выявления заболеваний терапевтического профиля или повышенного риска их возникновения, осуществление лечения выявленных заболеваний и состояний в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара на основе установленных стандартов медицинской помощи;

осуществление медицинской реабилитации лиц, перенесших острые заболевания терапевтического профиля или оперативные и эндоваскулярные (интервенционные) вмешательства в связи с заболеваниями терапевтического

профиля;

оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с заключением и рекомендациями врачей-специалистов;

оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах пациентам при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара;

направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам;

осуществление отбора и направления пациентов для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, представление их на врачебную комиссию, направление пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу;

выдача заключения о необходимости направления пациента по медицинским показаниям для реабилитации и лечения в санаторно-курортные организации;

взаимодействие в пределах компетенции с другими медицинскими организациями, страховыми медицинскими организациями;

участие в отборе пациентов для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также ведение учета лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "терапия";

участие в организации и проведении диспансеризации населения и дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с установленным порядком ее проведения;

анализ деятельности Кабинета, участие в мониторинге и анализе основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности на обслуживаемом участке;

осуществление внедрения в практику новых современных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов в амбулаторных условиях;

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам терапии (внутренние болезни);

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 2. Рекомендуемые штатные нормативы терапевтического кабинета*

* Рекомендуемые штатные нормативы терапевтического кабинета не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей
1.	Заведующий - врач-терапевт	1 (при количестве врачей-терапевтов участковых более 6,5 - вместо 0,5 должности врача, при числе врачей-терапевтов участковых более 9 - сверх этих должностей)
2.	Врач-терапевт участковый	1 на 1700 человек прикрепленного взрослого населения; 1 на 1300 человек прикрепленного взрослого населения (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, высокогорных, пустынных, безводных и других районов (местностей) с тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также для местностей с низкой плотностью населения)
3.	Медицинская сестра участковая	1 на 1 врача-терапевта участкового, кроме должностей, полагающихся на население приписного участка, обслуживаемого фельдшерско-акушерским пунктом
4.	Санитар	1 на 3 должности врача-терапевта участкового

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом

Приложение 3. Стандарт оснащения терапевтического кабинета

№ п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.
1.	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный	1
2.	Весы с ростомером	1
3.	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр	1
4.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками	не менее 1
5.	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи	1 набор
6.	Лента измерительная	1
7.	Лупа ручная	1
8.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)	1
9.	Стетфонендоскоп	1

Приложение № 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 4. Правила организации деятельности терапевтического отделения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности терапевтического отделения медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "терапия".

2. Терапевтическое отделение медицинской организации (далее - Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации.

3. Штатная численность Отделения утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#), утвержденному настоящим приказом.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

На должность заведующего Отделением и врача-терапевта назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым [Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](#), утвержденными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н](#), по специальности "терапия", а также [Квалификационными характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих](#), утвержденного [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н](#).

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением № 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#), утвержденному настоящим приказом.

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

палату интенсивной терапии;

кабинет заведующего;

кабинет для врачей;

процедурную.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

комнату для хранения медицинского оборудования;

комнату для медицинских работников;

кабинет старшей медицинской сестры;

помещение сестры-хозяйки;

помещение для осмотра больных;

буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для больных;

санитарную комнату;

комнату для посетителей;

учебный класс клинической базы.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

осуществление диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при заболеваниях терапевтического профиля, не требующих нахождения пациента в специализированном отделении для оказания медицинской помощи по профилю "терапия";

выявление у пациента медицинских показаний и подготовка к проведению специализированных лечебно-диагностических процедур с последующим переводом для их выполнения и дальнейшего лечения в специализированное отделение для оказания медицинской помощи по профилю "терапия" или отделение хирургического профиля;

осуществление реабилитации пациентов в стационарных условиях после основного лечения, в том числе хирургического и иного интервенционного, в специализированном отделении;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-диагностического процесса и внедрению в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов по профилю "терапия";

проведение санитарно-просветительной работы с пациентами, обучение их правилам первой помощи при неотложных состояниях, вероятность развития которых у них наиболее высокая;

оказание консультативной помощи врачам и иным медицинским работникам других подразделений медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний по профилю "терапия";

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам оказания медицинской помощи по профилю "терапия".

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно создано.

10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

Приложение № 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 5. Рекомендуемые штатные нормативы терапевтического отделения

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей
1.	Заведующий - врач-терапевт	1 на 30 коек*
* Минимальное число коек, при которых вводится должность заведующего терапевтическим отделением, составляет 20 коек, на которые вводится 2 должности врача-терапевта, один из которых выполняет функцию заведующего терапевтического отделения.		
2.	Врач-терапевт	1 на 15 коек

3.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
4.	Медицинская сестра процедурной	1 на 30 коек
5.	Старшая медицинская сестра	1
6.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Санитар	2 (для работы в буфете); 1 (для уборки помещений); 1 (для санитарной обработки больных)
8.	Сестра-хозяйка	1

Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 6. Стандарт оснащения терапевтического отделения

№ п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.
1.	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр	по количеству врачей
2.	Стетофонендоскоп	по количеству врачей
3.	Лупа ручная	1
4.	Неврологический молоток	1
5.	Электрокардиограф многоканальный	1
6.	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания*	1

* При отсутствии отделения (кабинета) функциональной диагностики.		
7.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)	2
8.	Весы медицинские	1
9.	Ростомер	1
10.	Спирометр	1
11.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке	1
12.	Концентратор кислорода	1 на 60 коек
13.	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный	3
14.	Игла для пункции, дренирования и проколов	2
15.	Нож (игла) парацентезный штыкообразный	2
16.	Игла для стеральной пункции	2
17.	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	1
18.	Консоль палатная прикроватная настенная**	по числу коек палаты интенсивной терапии
** При наличии палаты интенсивной терапии в структуре терапевтического отделения.		
19.	Кардиомонитор прикроватный**	по числу коек палаты интенсивной терапии

** При наличии палаты интенсивной терапии в структуре терапевтического отделения.		
20.	Насос инфузионный роликовый (инфузомат)	1 на 10 коек
21.	Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии**	по числу коек палаты интенсивной терапии
** При наличии палаты интенсивной терапии в структуре терапевтического отделения.		
22.	Набор реанимационный**	1
** При наличии палаты интенсивной терапии в структуре терапевтического отделения.		
23.	Матрац противопролежневый	1 на 10 коек
24.	Шкаф-укладка для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях	1
25.	Укладка (аптечка) "АнтиСПИД"	1
26.	Термометр медицинский	по потребности
27.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений)	по потребности
28.	Кровать функциональная	по числу коек
29.	Стол прикроватный	по числу коек
30.	Кресло туалетное (или туалетный стул)	1 на 10 коек
31.	Кресло-каталка	1 на 15 коек (не менее 2)
32.	Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная	1 на 15 коек (не менее 2)

33.	Штатив медицинский (инфузионная стойка)	1 на 5 коек (не менее 10)
34.	Негатоскоп	не менее 1
35.	Аспиратор (отсасыватель) медицинский	не менее 2
36.	Система палатной сигнализации	1

Приложение № 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 7. Правила организации деятельности терапевтического дневного стационара

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности терапевтического дневного стационара медицинской организации.
2. Терапевтический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для осуществления медицинской помощи по профилю "терапия" при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.
3. Штатная численность терапевтического дневного стационара устанавливается руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных [приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#), утвержденному настоящим приказом.
4. На должность заведующего терапевтического дневного стационара назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым [Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения](#), утвержденными [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 415н](#), по специальности "терапия", а также [Квалификационными характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих](#), утвержденного [приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н](#).

5. В структуре терапевтического дневного стационара рекомендуется предусматривать:

процедурную;

кабинет заведующего;

кабинеты для врачей.

6. В терапевтическом дневном стационаре рекомендуется предусматривать:

палаты для больных;

комнату для хранения медицинского оборудования;

помещение для осмотра больных;

пост медицинской сестры;

помещение сестры-хозяйки;

буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для больных;

санитарную комнату;

комнату для посетителей.

7. Оснащение терапевтического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным [приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"](#), утвержденному настоящим приказом.

8. Терапевтический дневной стационар осуществляет следующие функции:

оказание медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи по профилю "терапия" при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;

проведение санитарно-просветительной работы пациентов, обучение их оказанию первой помощи при наиболее вероятных неотложных состояниях, которые могут развиваться у пациента в связи с его заболеванием;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-диагностического процесса и внедрению в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации по профилю "терапия";

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний по профилю "терапия";

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 8. Рекомендуемые штатные нормативы терапевтического дневного стационара

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей
1.	Заведующий - врач-терапевт	1 на 30 коек
2.	Врач-терапевт	1 на 15 коек
3.	Старшая медицинская сестра	1 на 30 коек
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	1 на 15 коек
5.	Медицинская сестра процедурной	1 на 15 коек
6.	Санитар	2 (для работы в буфете); 1 (для уборки помещений);

		1 (для санитарной обработки больных)
--	--	--------------------------------------

Приложение № 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 923н

Приложение 9. Стандарт оснащения терапевтического дневного стационара

№ п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.
1.	Набор реанимационный	1
2.	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный	1
3.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений)	по потребности
4.	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания*	1
* При отсутствии отделения (кабинета) функциональной диагностики в структуре медицинской организации.		
5.	Ростомер	1
6.	Стетофонендоскоп	1
7.	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр	1
8.	Штатив для длительных инфузионных вливаний	1 на 1 койку
9.	Термометр медицинский	по потребности
10.	Кровать функциональная	по числу коек
11.	Стол прикроватный	по числу коек

12.	Негатоскоп	1
13.	Аспиратор (отсасыватель) медицинский	2
14.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	1
15.	Укладка "АнтиСПИД"	1

© Материал из Справочной системы «Консилиум»

<https://1crs.ru>

Дата копирования: 27.08.2025